

Die ersten 8 Wochen nach der letzten Dosis

Die Absetz-Studien zeigen immer denselben Verlauf: ein paar ruhige Wochen, dann ab etwa Woche 8 die Zunahme.¹ Diese Checkliste ordnet die acht Wochen davor. Sie sagt nicht, ob oder wann du absetzt; das legst du mit deiner Ärztin oder deinem Arzt fest. Sie sagt, was du in dieser Zeit für Muskeln, Gewicht und Alltag tun kannst.

Ob und wie du dein Medikament absetzt, besprichst du mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.

So nutzt du die Liste

Woche 0 ist die Woche der letzten Dosis. Die Wochen danach zählen ab diesem Datum. Nicht alles muss auf einmal passieren; die Reihenfolge ist Absicht: erst messen und Protein, dann Training, dann Steigerung. Wer die Liste vor der letzten Dosis anfängt, hat es leichter, weil der Appetit noch klein ist.

Woche 0: die letzte Dosis

-
- ☐ Datum der letzten Dosis notieren. Ab hier zählen die Wochen.
 - ☐ Wissen, wie lange der Wirkstoff bleibt: Semaglutid hat laut Fachinformation eine Halbwertszeit von etwa einer Woche, die Wirkung klingt über fünf bis sieben Wochen aus; Tirzepatid etwa vier Wochen, Liraglutid wenige Tage.³
 - ☐ Ausgangswerte messen und aufschreiben: Gewicht (morgens, nüchtern), Taillenumfang, Griffkraft oder die Zeit für fünfmal Aufstehen vom Stuhl.
-

Woche 1 bis 2: die Auswaschphase

Der Wirkstoff ist noch da, der Appetit klein. Das ist die Zeit, um Gewohnheiten aufzubauen, bevor der Hunger zurück ist.

-
- ☐ Drei Mahlzeiten mit je 25 bis 30 g Protein planen. Übersichtsarbeiten empfehlen beim Abnehmen und beim Halten des Gewichts 1,2 bis 1,6 g Protein pro kg Körpergewicht und Tag;⁴ pro Mahlzeit brauchen Ältere mehr als Jüngere.⁵
 - ☐ Zwei Krafteinheiten in dieser Woche, je 30 Minuten, sechs Übungen für den ganzen Körper. Die WHO empfiehlt mindestens zwei Tage pro Woche.⁶ Einsteiger: 8 bis 12 Wiederholungen, zwei Sätze.⁷
 - ☐ Wiegetag festlegen: einmal pro Woche, morgens, gleiche Bedingungen. Nicht täglich.
 - ☐ Ballaststoffe Richtung 30 g pro Tag (DGE-Richtwert),⁹ mit reichlich Wasser.
 - ☐ Schlaf schützen: Schon zwei Nächte mit vier Stunden Schlaf erhöhen das Hungerhormon Ghrelin messbar.¹⁰
-

Woche 3 bis 4: der Appetit kommt zurück

-
- ☐ Mahlzeitenstruktur beibehalten, auch wenn der Hunger zwischendurch kommt: Nach Gewichtsverlust bleiben Hungerhormone über Monate erhöht.¹¹ Das ist Biologie, kein Willensproblem.
 - ☐ Umgebung aufräumen: Was nicht in Sichtweite steht, lockt weniger. Vorräte für die Proteinmahlzeiten anlegen.
 - ☐ Training: bei zwei Sätzen bleiben und die Wiederholungen Richtung 12 steigern. Der dritte Satz kommt erst ab Woche 5, wie im [12-Wochen-Plan](#).⁷
 - ☐ Optional Kreatin-Monohydrat, 3 g täglich, nur zusammen mit dem Training: Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung.¹² Bei Nierenerkrankungen vorher fragen.¹³
 - ☐ Taillenumfang messen, neben dem Gewicht notieren.
-

Woche 5 bis 6: steigern

- ☐ Dritter Satz dazu, sobald zwei Sätze mit 12 sauberen Wiederholungen gelingen; dann zurück auf 8 Wiederholungen. Belastung erhöhen: stärkeres Band, mehr Gewicht oder die schwerere Variante der Übung. Das ACSM empfiehlt Schritte von etwa 2 bis 10 %.⁷
 - ☐ Alltagsbewegung zählen: Schritte, Treppen, Wege zu Fuß. Die WHO empfiehlt zusätzlich 150 bis 300 Minuten moderate Bewegung pro Woche.⁶
 - ☐ Zweite Messung: Griffkraft oder Aufsteh-Test. Steigt der Wert, wirkt das Training, egal was die Waage sagt.
 - ☐ Protein prüfen: Kommen an Trainingstagen wirklich drei Portionen zusammen?
-

Woche 7 bis 8: die Absetzkurve beginnt

Ab etwa Woche 8 wird die Zunahme in Studien messbar und ist bis Woche 20 am steilsten.¹ Jetzt zählt der Wochentrend.

- ☐ Nur den Wochentrend lesen, nicht den Tageswert. Ein bis zwei Kilo Schwankung sind Wasser und Speicher, kein Fett.
 - ☐ Regel für den Anstieg: Liegt das Wochenmittel mehr als 1,4 kg über dem Ausgangswert, zwei Wochen lang zuerst Protein und Bewegung prüfen, nicht hungern; ab 2,3 kg den Plan prüfen.¹⁴ Hungern kostet Muskeln.
 - ☐ Bilanz nach acht Wochen: Was hat funktioniert, was fällt aus? In der S-LiTE-Studie hielten Menschen, die trainierten, Gewicht und Körperzusammensetzung ein Jahr nach dem Ende aller Behandlungen.⁸
-

Und danach

Die Haltephase dauert länger als acht Wochen. Ein Jahr nach dem Absetzen von Semaglutid waren in der STEP-1-Verlängerung im Mittel zwei Drittel des verlorenen Gewichts wieder da.² Was in Studien hilft, steht unter Gewicht halten nach der Abnehmspritze (nachderspritze.de/wissen/gewicht-halten-nach-abnehmspritze/). Einen Trainingsplan für zwölf Wochen findest du

unter Krafttraining nach der Abnehmspritze

(nachderspritze.de/wissen/krafttraining-nach-abnehmspritze/).

Wann du zur Ärztin oder zum Arzt gehst

- Bei Typ-2-Diabetes: sobald Blutzuckerwerte steigen.
- Sofort bei Atemnot, Herzrasen, starken Bauchschmerzen oder Anzeichen einer Unterzuckerung (Zittern, Schwitzen, Verwirrtheit).
- Bei Übelkeit oder gedrückter Stimmung, die länger als zwei Wochen anhält.
- Bei der Frage, ob und wie das Medikament abgesetzt oder wieder begonnen wird. Das entscheidet niemand allein.

Diese Checkliste ist eine allgemeine Information und ersetzt keine ärztliche Beratung. Das 12-Wochen-Programm von Nach der Spritze ist ein Trainings- und Ernährungsprogramm, kein Medikament, und verhindert den Jojo-Effekt nicht.

Quellen

- 1 Wu H, Yang W, Guo T, et al. Trajectory of the body weight after drug discontinuation in the treatment of anti-obesity medications. BMC Med. 2025;23:398. Zur Quelle
Meta-Analyse von RCTs: Ab etwa Woche 8 nach dem Absetzen ist die Gewichtszunahme messbar, sie setzt sich bis etwa Woche 20 fort.
- 2 Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24(8):1553–1564. Zur Quelle
Ein Jahr nach dem Absetzen waren im Mittel zwei Drittel des verlorenen Gewichts wieder da: nach 68 Wochen Semaglutid –17,3 % (Placebo –2,0 %), nach 120 Wochen –5,6 % (Placebo –0,1 %), also 11,6 Prozentpunkte zurück.
- 3 Europäische Arzneimittel-Agentur. Wegovy (Semaglutid): Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Amsterdam: EMA. Zur Quelle
Fünf Dosisstufen von 0,25 bis 2,4 mg; Halbwertszeit etwa eine Woche; nach der letzten Dosis von 2,4 mg etwa sieben Wochen im Blut nachweisbar; bei geplanter Schwangerschaft mindestens zwei Monate vorher absetzen.
- 4 Leidy HJ, Clifton PM, Astrup A, et al. The role of protein in weight loss and maintenance. Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1320S–1329S. Zur Quelle
Empfiehl für Gewichtsabnahme und -erhalt eine Proteinzufuhr von 1,2–1,6 g pro kg Körpergewicht und Tag, mit mindestens etwa 25 bis 30 g pro Mahlzeit.
- 5 Moore DR, Churchward-Venne TA, Witard O, et al. Protein Ingestion to Stimulate Myofibrillar Protein Synthesis Requires Greater Relative Protein Intakes in Healthy Older Versus Younger Men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015;70(1):57–62. Zur Quelle
Pro Mahlzeit etwa 0,24 g Protein pro kg Körpergewicht bei jüngeren und 0,40 g/kg bei älteren Männern, um die Muskelproteinsynthese maximal anzuregen.
- 6 World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Genf: WHO; 2020. Zur Quelle
Erwachsene: an mindestens zwei Tagen pro Woche muskelkräftigende Aktivitäten für alle großen Muskelgruppen.
- 7 American College of Sports Medicine. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults (Position Stand). Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687–708. Zur Quelle
Einsteiger: 8–12 Wiederholungen, 1–3 Sätze, 2–3 Einheiten pro Woche, Belastung schrittweise steigern.
- 8 Jensen SBK, Blond MB, Sandsdal RM, et al. Healthy weight loss maintenance with exercise, GLP-1 receptor agonist, or both combined followed by one year without treatment: a post-treatment analysis of a randomised placebo-controlled trial. eClinicalMedicine. 2024;69:102475. Zur Quelle
Ein Jahr nach Therapieende: Wer trainiert hatte, hielt Gewicht und Körperzusammensetzung; nach Liraglutid allein kam das Gewicht zurück (6,0 kg mehr Zunahme als nach Training allein, 95-%-KI 2,1 bis 10,0; 2,5 kg mehr als nach Training plus Liraglutid, –1,5 bis 6,5, nicht signifikant). Von Studienbeginn bis Woche 104 lag die Gruppe mit Training plus Liraglutid 5,1 kg (–10,0 bis –0,2) und beim Körperfettanteil 2,3 Prozentpunkte (–4,3 bis –0,3) unter Liraglutid allein.

- 9 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr: Ballaststoffe. Bonn. Zur Quelle
Richtwert mindestens 30 g pro Tag für Erwachsene.
- 10 Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief Communication: Sleep Curtailment in Healthy Young Men Is Associated with Decreased Leptin Levels, Elevated Ghrelin Levels, and Increased Hunger and Appetite. *Ann Intern Med.* 2004;141(11):846–850. Zur Quelle
Zwei Nächte mit vier Stunden im Bett gegenüber zwei Nächten mit zehn Stunden, 12 gesunde junge Männer: Leptin –18 %, Ghrelin +28 %, Hunger +24 %, Appetit +23 %, Appetit auf kalorienreiche Lebensmittel mit viel Kohlenhydraten +33 bis 45 %.
- 11 Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-Term Persistence of Hormonal Adaptations to Weight Loss. *N Engl J Med.* 2011;365:1597–1604. Zur Quelle
Ein Jahr nach einer Diät waren appetitsteigernde Hormonveränderungen (u. a. mehr Ghrelin, weniger Leptin) weiterhin messbar.
- 12 Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel; ergänzt u. a. durch Verordnung (EU) 2017/672 (Kreatin und Krafttraining ab 55 Jahren). Zur Quelle
Grundlage aller gesundheitsbezogenen Aussagen zu Lebensmitteln und Nahrungsergänzung auf dieser Seite.
- 13 Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017;14:18. Zur Quelle
Kreatin-Monohydrat gilt bei gesunden Erwachsenen in üblichen Dosen (3–5 g/Tag) als sicher und gut untersucht.
- 14 Wing RR, Tate DF, Gorin AA, Raynor HA, Fava JL. A self-regulation program for maintenance of weight loss. *N Engl J Med.* 2006;355(15):1563–1571. Zur Quelle
Randomisierte Studie, 314 Erwachsene nach mindestens 10 % Gewichtsverlust, 18 Monate: tägliches Wiegen mit Zonen (grün bis +1,4 kg, gelb bis +2,3 kg, rot ab +2,3 kg) und festgelegter Reaktion. 45,7 % der persönlich betreuten Gruppe nahmen 2,3 kg oder mehr wieder zu, 72,4 % der Kontrollgruppe.